32. L'APPAREIL GÉNITAL INFERIEUR

DURÉE : 08:54 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo immersive sur l'Appareil Génital Inférieur, nous explorons l'embryologie du vagin et de l'utérus, en mettant en lumière la dynamique de croissance postérieure qui forme ces structures essentielles. L'équilibre gynécologique est abordé à travers l'analyse des mouvements entre le sacrum et le péritoine, et comment ces interactions affectent la santé des organes reproducteurs. En se concentrant sur des déséquilibres tels que les fausses couches ou l'endométriose, la vidéo propose des techniques thérapeutiques fascinantes basées sur des concepts de nettoyage énergétique, d'équilibre fascial et de liens transgénérationnels. Cette approche permet aux praticiens d'apprendre à

L'APPAREIL GÉNITAL INFÉRIEUR : APPROCHE BIODYNAMIQUE

EMBRYOLOGIE DU VAGIN ET DE L'UTÉRUS

L'insertion de la **vessie** au niveau du **tubercule de Müller**, situé dans le sinus urogénital, est essentielle. Cette zone comprend la vessie, l'urètre et l'attache au niveau du vagin.

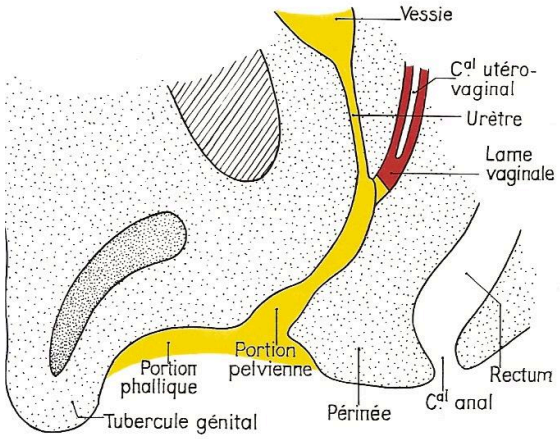


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

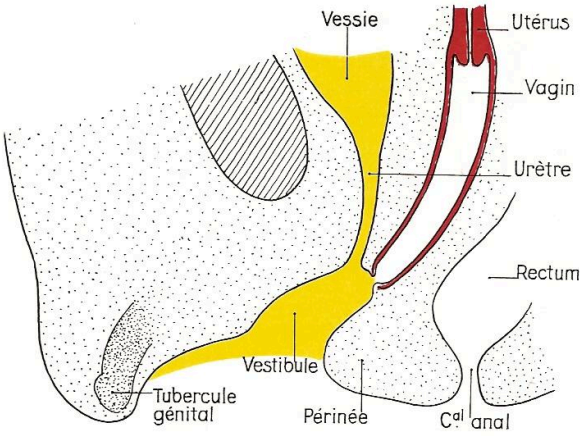


Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

FIG. — Développement tractus urogénital femelle

Le vagin dérive du **mésoderme**, spécifiquement du canal de Müller. La formation des **lames vaginales** résulte de la croissance postérieure du sacrum et du tube neural.

La vitesse de croissance différentielle de cette partie postérieure crée l'espace d'ouverture du vagin. C'est le mouvement **postéro-antérieur**, entre le rein et le sacrum, qui permet cette extension.

Le tubercule de Müller s'épaissit puis est étiré, non par une traction superficielle, mais par la poussée plus rapide de la partie postérieure. Ce phénomène conduit à l'allongement et à la formation du vagin et du col de l'utérus.

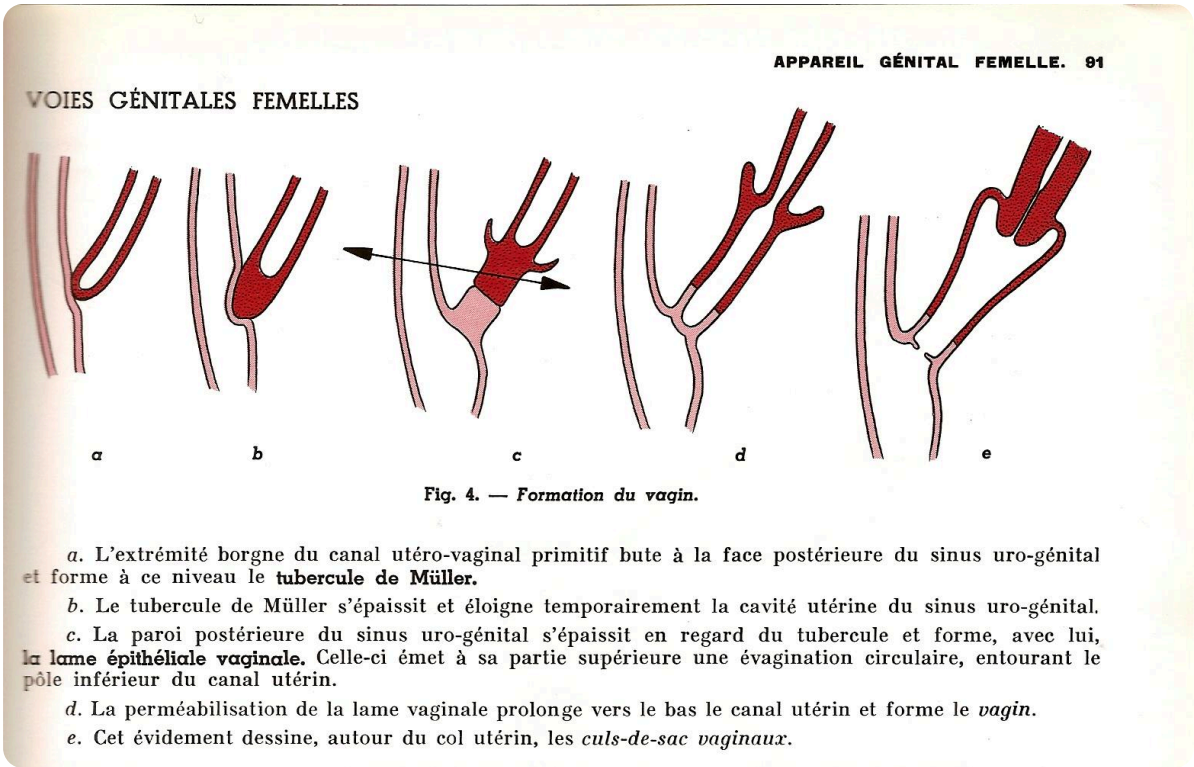


FIG. — Vaginogenèse

La paroi postérieure du sinus urogénital s'épaissit, donnant naissance aux lames vaginales qui s'ouvrent et s'étirent. Cette dynamique est similaire, avec la partie postérieure grandissant plus rapidement.

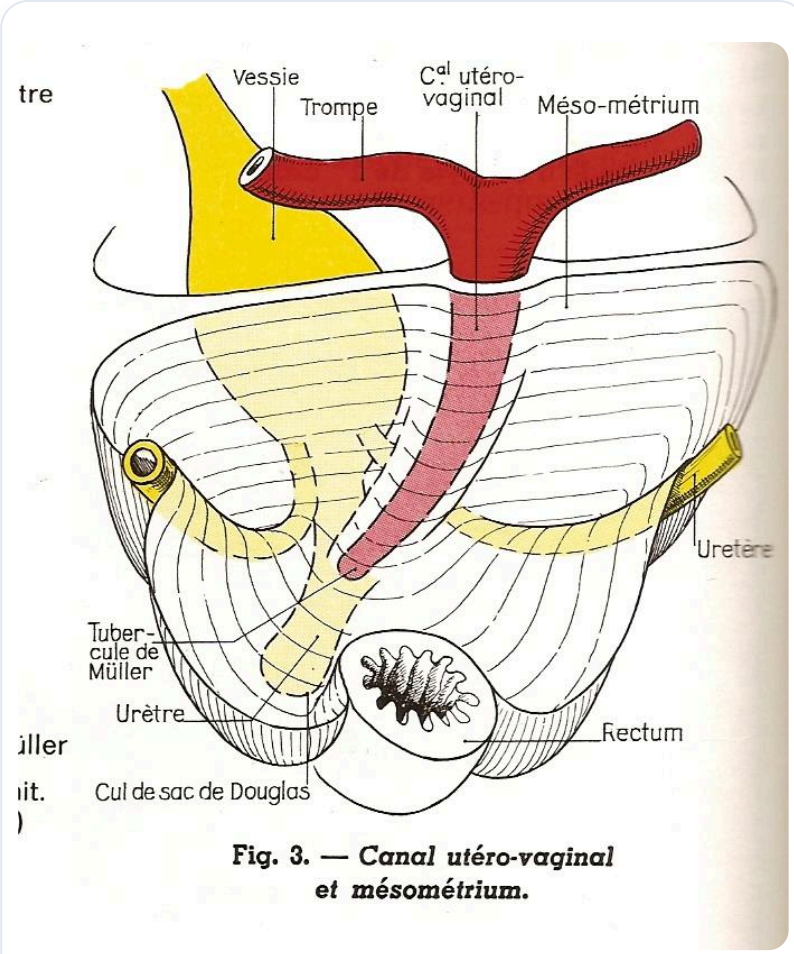


Fig. 3. — *Canal utéro-vaginal et mésométrium.*

FIG. — Canal utéro-vaginal

ÉQUILIBRE GYNÉCOLOGIQUE ET MOUVEMENT BIODYNAMIQUE

Lors de l'examen de l'utérus, un mouvement entre le **sacrum** et le **péritoine** est perçu. C'est dans l'interaction de ces deux pôles que se trouvent l'équilibre vaginal et utérin.

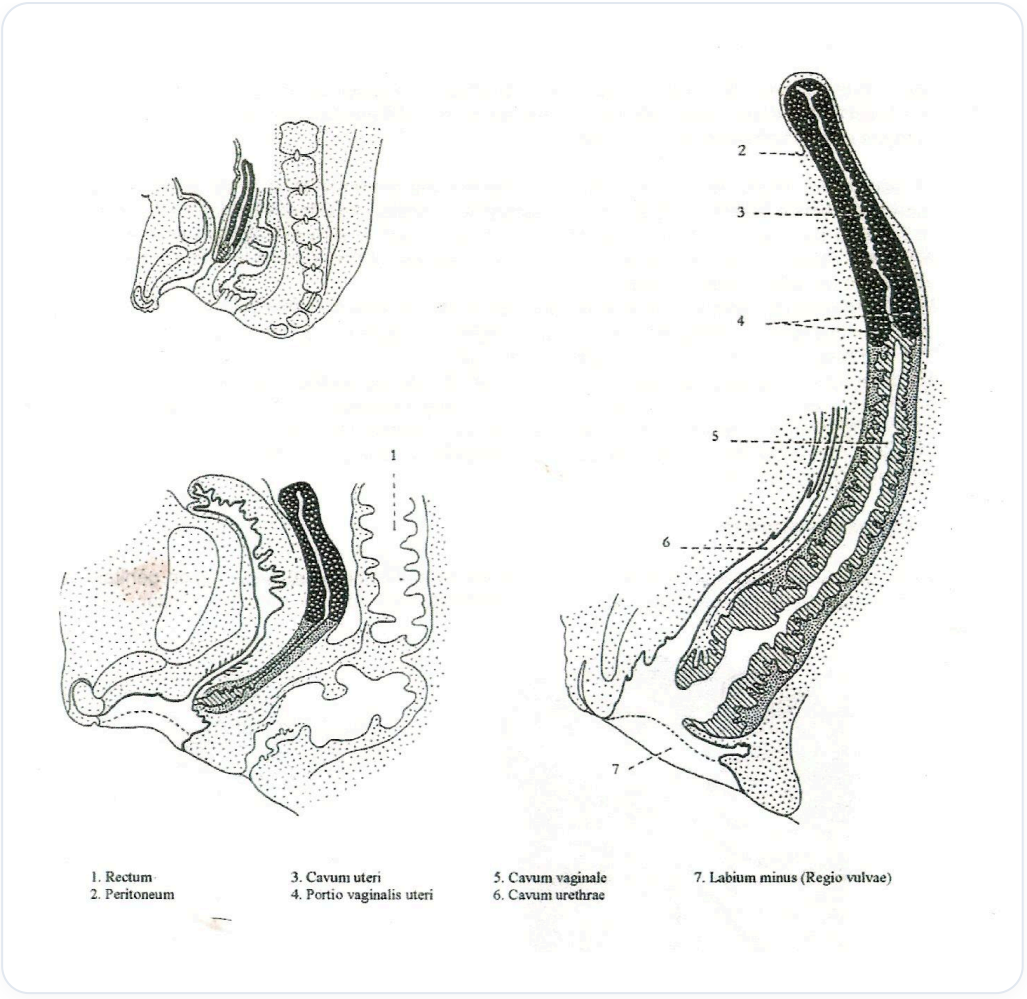


FIG. — Anatomie utérine féminine

Au niveau gonadique, un mouvement inverse est ressenti au niveau du ventre, suivant le ligament en direction du pubis, tel une vague qui descend.

La descente du sacrum est influencée par le tube neural. Un autre point d'appui crucial est la combinaison du pubis et du sacrum, formant un équilibre fascial essentiel du petit bassin chez la femme.

Cet équilibre implique une ligne de force descendante relative au sacrum, influençant diverses fonctions du corps féminin.

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DES DÉSÉQUILIBRES UTÉRINS

Des situations comme les **fausses couches** laissent une empreinte énergétique dans l'utérus. Un nettoyage énergétique de l'utérus devient alors nécessaire.

Nous pouvons aborder l'utérus avec une **force magnétique**, apprenant à ressentir le champ énergétique à distance. Le praticien perçoit une fréquence, une zone de chaleur qui se densifie, signe de l'énergie en présence.

Mon approche consiste à "scanner" et identifier les zones nécessitant un nettoyage. Il s'agit de redonner de la liberté aux tissus et aux énergies.

Une **rétroversion utérine**, par exemple, peut entraîner des phases congestives. Le travail à distance vise à rééquilibrer le système gynécologique, en lien étroit avec la **gastrine**.

L'**endométriose**, caractérisée par une prolifération de tissu remontant dans le péritoine, est souvent associée à des douleurs lombaires et sacro-iliaques.

LA CAVITÉ INTRA-PÉRITONÉALE ET LA DIMENSION TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Chez la femme, il existe un lien direct entre le col de l'utérus, les trompes et la **cavité intra-péritonéale**. Cette cavité est d'une grande importance, perçue comme un "ciel" ou un espace primordial.

Chaque état du corps représente la meilleure réponse fonctionnelle possible à un instant donné. Cette réponse est influencée par notre vie, mais aussi par celle de nos ancêtres.

Une rétroversion utérine, par exemple, peut être la meilleure réponse que le corps a trouvée pour résoudre un problème **transgénérationnel** ou personnel profond.

Il est essentiel de comprendre pourquoi un schéma transgénérationnel se manifeste ainsi. La thérapie vise à décoder cette "meilleure réponse" et à offrir la libération nécessaire, si elle est demandée.

L'embryon illustre parfaitement cette notion : à chaque stade de développement, il présente la meilleure réponse physiologique possible.

LA NEURULATION SECONDAIRE ET LA FORMATION DU PHILUM TERMINAL

Le **tube neural** est associé à une éminence caudale postérieure, créant un espace de lumière et de connexion. On observe le bourgeon caudal et la partie terminale de la **notochorde**.

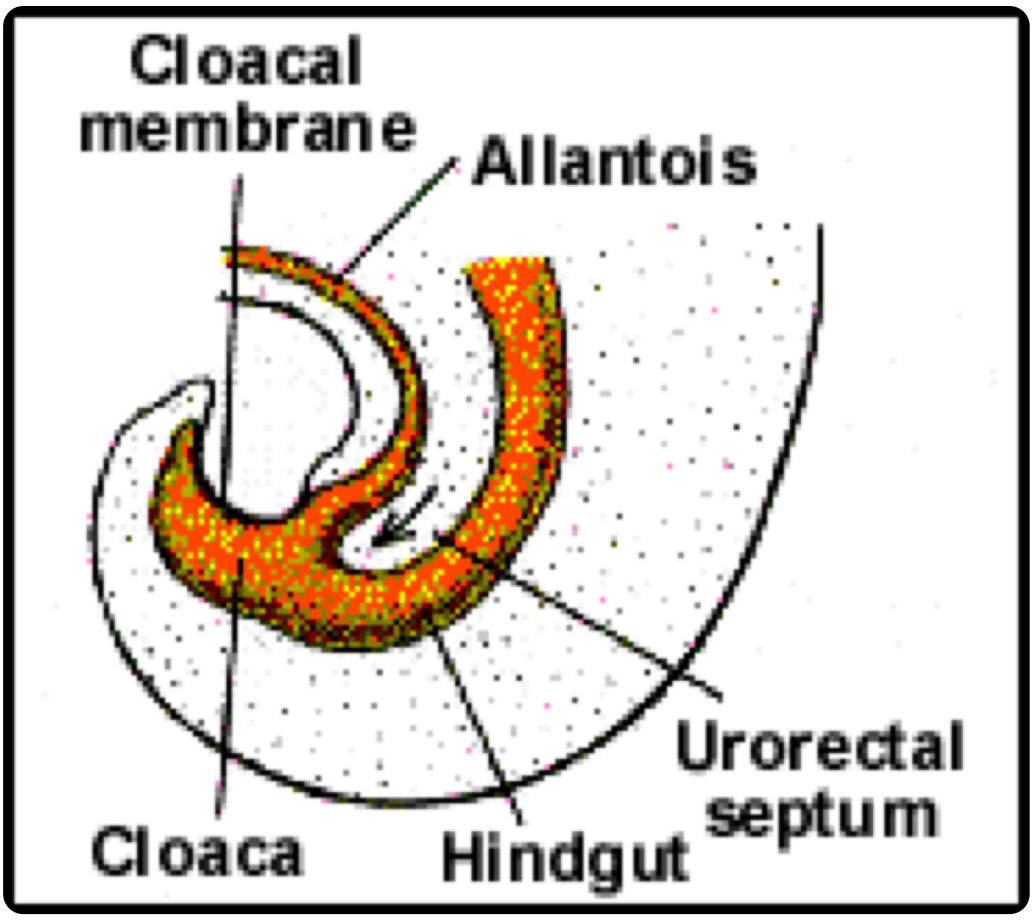


FIG. — Développement cloacal embryonnaire

L'espace du rectum et le tube neural avec le neuropore postérieur sont en étroite relation. Une connexion se forme grâce à un mouvement développemental plus prononcé à la partie postérieure.

Celle-ci implique une fermeture puis une réouverture pour établir cette connexion. Ce processus aboutit à l'émergence du neuropore postérieur et à l'allongement pour former le **philum terminal**.

C'est ce que l'on nomme la **neurulation secondaire**. La manipulation du sacrum révèle ces vitesses de croissance différentielles, où la jonction initiale s'allonge postérieurement.

L'intégration de l'éminence caudale assure la continuité avec le tube neural, formant cette neurulation secondaire ascendante.

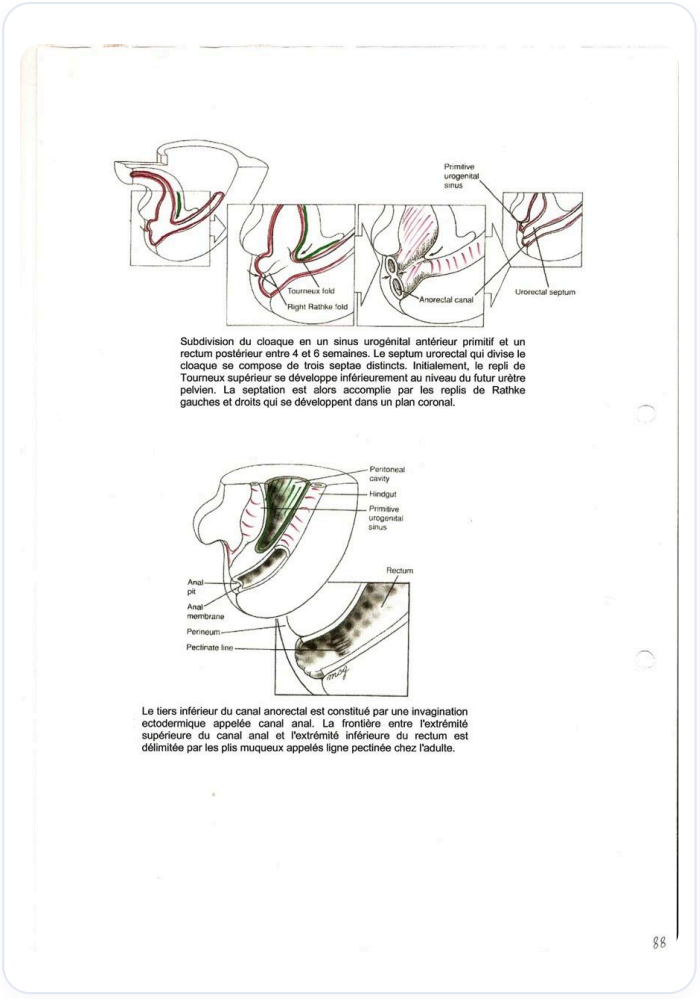


FIG. — Septation du cloaque

DÉVELOPPEMENT DU PÉRINÉE ET INFLUENCE HÉPATIQUE

Au niveau du **périnée**, nous observons l'émergence des membres inférieurs et une traction qui s'exerce. Ce mouvement est profondément lié au système utérin.

La bascule du **foie**, en synergie avec la descente du tube neural et du sacrum, influence le mouvement de développement qui tire vers la ligne blanche, via le ligament falciforme.

Ce développement hépatique entraîne une bascule qui affecte l'ensemble de la zone utérine en développement. Il pourrait expliquer des phénomènes de migration ou de tractions différentielles liées à la position utérine.

Un ligament se développe entre le pubis et l'ombilic, encapsulant l'histoire de la descente et de la formation utérine.

Comme le sternum contient l'histoire de notre flexion, ce ligament ventromédial (sur la ligne blanche) concentre l'histoire de toute la formation postérieure, de la **gonadisation** et de l'**utérisation** du bassin.

La ligne blanche est la rencontre de toute l'histoire **urogénitale**.